

Fecha Última Actualización: 13-10-2022 15:28:54

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Iris Del Carmen Pavez Ortiz
Edad : 76a 2m 6d
Dirección : Los Zapotecas 0906

Rut : 5.926.546-6
Fecha Nacto: 07/08/1946
Comuna : La Pintana

N° Archivo : 1511903
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4926 6359

N° Epicrisis
309135

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Ingreso : 18/04/2022 16:38

Días Estadía: 178

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 13/10/2022 15:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Aneurisma Y Disección Aórticos

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Traqueostomía (Proc. Aut.) - 12/05/2022 11:30 - Paula Carolina Gaete Cartagena
Mediastinotomía Exploradora Ant. O Post. C/S Biopsia Proc. Aut - 03/05/2022 11:15 - Demian Andres Fullerton Moreno
Ecocardiograma Bidimensional Doppler Color Transesofágico - 21/04/2022 08:30 - Demian Andres Fullerton Moreno
Tratamiento Quirurgico Grandes Vasos Con Cec - 21/04/2022 08:30 - Demian Andres Fullerton Moreno
Tratamiento Quirurgico Recambio Dos O Mas Valvulas - 21/04/2022 08:30 - Demian Andres Fullerton Moreno

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Iris Pavez Ortiz
RUT: 5926546-6
Edad: 76
Fecha Ingreso HSR: 18/04/22
Fecha Ingreso UTIM: 20/09/22

Anamnesis remota:

- Antecedentes médicos: HTA, ICC, Insuficiencia Aórtica Moderada, FeVI estimada en 69%
- Antecedentes quirúrgicos: -
- Medicamentos: -
- Alergias: -
- Hábitos: -
- Inmunizaciones: -
- Hospitalizaciones recientes: -
- Antecedentes sociales: -

Motivo de consulta: derivada para cardiocirugía

Historia actual:

Paciente con cuadro de 5 meses de evolución caracterizada por disnea progresiva que evoluciona hasta mínimos esfuerzos, por lo que consulta en APS, siendo derivada a nivel terciario para estudio en julio 2021. Evaluada en forma inicial por Dr Salgado, se solicita AngioTC TAP, en donde destaca como hallazgo dilatación aneurismática de la aorta torácica ascendente, alcanzando un diámetro anteroposterior máximo de 72 mm, desde unión sinotubular hasta emergencia de innominada, motivo por el cual se decide su ingreso de forma electiva para reparación quirúrgica (Reemplazo Valvular Aórtico y Reemplazo de Aorta Ascendente con canulación de Innominada)
Ingresa electivamente el 18/04.

Fecha Epicrisis : 13/10/2022 15:28

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:00

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Evolución en UCI

Hemodinamia/Cardiociugía: 21/04 cirugía de reemplazo de aorta ascendente con prótesis dacrón y recambio valvular aórtico con válvula biológica, en el postoperatorio inmediato con requerimiento de DVA. 03/05 evoluciona con hemomediastino que requiere reexploración quirúrgica y aseo quirúrgico con drenaje de líquido pleural, cursó con deterioro HDN y necesidad de NAD y adrenalina. 09/05 shock séptico prolongado, se planteó ISR relativa, se adicionó Hidrocortisona, logrando su suspensión el 11/05. Durante hospitalización con inestabilidad eléctrica, múltiples episodios de FA +/- flutter, requirió CVE el 23/04 y 03/05, además de múltiples cargas de amiodarona. Último deterioro hemodinámico severo 16/08 post drenaje de colección periprotésica, requirió altas dosis de noradrenalina + adrenalina actualmente con dosis en descenso que se logra suspensión. Además presentó síndrome taquicardia-Bradicardia; se realiza Holter de ritmo que muestra algunos episodios de bradicardia sinusal intercalados con taquicardia, con ESV frecuentes. Se decide instalación de MCP definitivo, realizado sin incidentes. Días previo al traslado presentó FA con RVR, se administró lanatosido C y actualmente con amiodarona enteral en dosis de carga, no ha repetido arritmia. Vigilar

Respiratorio: Inicialmente en VMI post pabellón, extubada el 25/04 con salida a VMNI y luego CNAF. Evolucionó con delirium hiperactivo, agitación y mala mecánica, requiriendo reintubación el 01/05. Post intubación presentó enfisema subcutáneo, se retiró TOT y se reintubó con videolaringoscopia dada vía aérea difícil. TC tórax 01/05, destacó posible solución de continuidad de bronquio fuente izquierdo, acentuado neumomediastino, leve neumotórax derecho y neumoperitoneo, además de leve derrame pleural bilateral, mayor a izquierda. Se desestimó estudio dirigido para descartar lesiones de esófago o vía aérea. Por weaning prolongado se realizó TQT quirúrgica, el 12/05 por equipo de cirugía cardíaca, sin incidentes, logrando destete de VMI el 23/05. Difícil rehabilitación por ansiedad, auto retiro de TQT en episodio de crisis ansiosa. Re ingresa a UCI conectada a Asistencia Respiratoria mecánica, con weaning dificultoso y prolongado en contexto de falta de fuelle. Posteriormente evoluciona con múltiples cambios de TQT y necesidad intermitente de conexión a VMI. Actualmente con TQT a filtro desde hace 48 hrs, sin conflicto de intercambio gaseoso PAFI >300, buen patrón respiratorio, en plan de rehabilitación por equipo de fonoaudiología.

TAC tórax 01/05: Tubo endotraqueal con su extremo distal en el bronquio fuente derecho. Probable solución de continuidad de la pared posterior del bronquio fuente izquierdo. Acentuado neumomediastino, leve neumotórax derecho, neumoperitoneo parcialmente visible y acentuado enfisema subcutáneo en pared torácica y cervicofacial. Leve a moderado derrame pleural mayor izquierda. Atelectasias pasivas en lóbulos inferiores. Cardiomegalia y derrame pericárdico con componente de hemopericardio.

TAC TAP 04/06: Resolución del neumomediastino, neumotórax y enfisema del tejido celular subcutáneo. Pequeña colección en formación en mediastino anterior. Leve derrame pleural bilateral, mayor a izquierda. Moderada cardiomegalia. Leve ascitis en excavación pelviana.

TC TAP 28/6: Aparición de opacidades con densidad en vidrio esmerilado en LSD y lóbulo inferior ipsilateral de probable etiología inflamatoria infecciosa. Leve derrame pleural bilateral y opacidades atelectásicas en ambos lóbulos inferiores estables en cuenta en comparación a estudio previo. Escaso líquido retroesternal no organizado estable en comparación a estudio previo. Contenido denso en las porciones dependientes de la vesícula que puede estar determinado por barro biliar y/o microlitiasis. Ateromatosis cálcica difusa de la aorta abdominal. Moderada cardiomegalia global.

Cintigrama óseo 02/07: Examen sin evidencias cintigráficas de focos infecciosos óseos. El hallazgo descrito en esternón es sugerente de cambios post quirúrgicos de esternotomía media reciente. Cambios de aspecto degenerativo en el resto de las localizaciones descritas.

TC tórax 25/07: Leve derrame pleural bilateral. Colección adyacente a la aorta torácica ascendente, de probable carácter postquirúrgico, nueva en comparación a estudio previo. Leve cardiomegalia a expensas de cavidades cardíacas derechas.

AngioTC tórax 22/08: Leve aumento de tamaño de colección organizada adyacente a la aorta torácica ascendente. Moderado derrame pleural derecho y leve izquierdo que han aumentado su cuantía con respecto a estudio previo. TTC tórax 25/07: 1. Leve derrame pleural bilateral. Colección adyacente a la aorta torácica ascendente, de probable carácter postquirúrgico, nueva en comparación a estudio previo. Leve cardiomegalia a expensas de cavidades cardíacas derechas. rombo periférico escaso no oclusivo en vena yugular interna derecha.

Diagnósticos de Traslado a UTIM

Prótesis valvular aórtica biológica (Trifecta #21) + Reemplazo de aorta ascendente 21/04

- Toracotomía exploradora + Aseo y drenaje de 1200 ml hemotórax bilateral y hemomediastino 03/05
- VMI post pabellón hasta 25/04. 2° VMI 01/05 - 23/05. TQT quirúrgica #7.0 (12/05)

Múltiples complicaciones infecciosas:

- Shock séptico resuelto: ITU bacteriémica por K. pneumoniae MS - ITU por Enterococcus Faecium van A. Ambas tratadas.
- NAVM por PsAe MS. Resuelta

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 13-10-2022 15:28:54

Página 3 de 3

· Infección por Klebsiella pneumoniae BLEE de foco respiratorio y urinario. Tratada
· Colección peri-protésica drenada. 16/08/22
· Bacteremia por Elizabetkingia meningoseptica S a cotri
Síndrome de bradicardia-taquicardia - Marcapasos definitivo instalado
· Bradicardia sinusal obs ENS
· FA/flutter con RVR
· Sin anticoagulación
Shock postoperatorio resuelto (Obs distributivo + hemorrágico vs hemorrágico)
Síndrome convulsivo en tratamiento (FAE)
Bicitopenia multifactorial:
· Trombocitopenia severa obs secundaria a sepsis + linezolid. Resuelta
· Anemia moderada multifactorial
Paciente crítico crónico. Falta de fuelle respiratorio.
Antecedentes: HTA, ICC FEVI 69%, insuficiencia aórtica moderada, nódulo tiroideo 11x10 mm.

Paciente crítica crónica se traslada a UTIM para rehabilitación. Durante estadía dado paciente con hospitalización prolongada y deterioro consecuente, se decide en conjunto con familia manejo proporcional, sin orden de reanimación. Durante hospitalización en UTIM paciente cursa con hits infecciosos, que condicionan detención en avance de rehabilitación. El día 13/10 se evalúa paciente dado compromiso de conciencia abrupto. Se evalúa paciente cianótica a la inspección, no responde a estímulos, no ventila espontáneamente, sin pulso central, pupilas arreactivas a la luz. Se evalúa con ecoscopia que evidencia cámara cardíaca sin contractilidad. Dado manejo proporcional de paciente se decide no reanimar y se establece fallecimiento a las 14.50 hrs. Me comunico con familiares, emito certificado de defunción y epicrisis.

Diagnóstico de Egreso

Mediastinitis - Resuelta
Aneurisma de aorta ascendente -
Insuficiencia aórtica sintomática -
Fibrilación auricular de reciente inicio -
Miopatía del paciente crítico -
Trastorno de deglución -
Delirium -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :
Régimen Alimentario :
Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Daniela Belén Reyes González
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 13/10/2022 15:28

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:00

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar